

العمر(تاريخ الميلاد) : 02-04-1968 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي (-----)
المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

خطه العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي
الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونك [14157]
التعليق على التشخيص : -----

الاسم: د/محمد كيلاني
 الاسم: د/ندى حسن
 الاسم: د/نرمين رمضان
 الوظيفة: _____
 الوظيفة: _____
 الوظيفة: _____
 أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس
 وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
 كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

التشخيص النهائي :
 خطة العلاج :
 المستشفى :
 قسم :
 جهة العلاج :
 ملاحظات :
 نفقات :

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

Name: هدى محمد عبد الحميد سلامة
National ID: 26804020103582



تقرير طبي

السيد

تحية طبية وبعد,,

بشأن تقرير طبي للمريض

إيماء للطلب المقدم من

رقم طبي:

بقسم:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته

تاريخ وساعة الخروج :
PM 01:17 05-07-2026

تاريخ وساعة الدخول :
-- --:-- yyyy-mm-dd

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

الوقت :

-- --:--

التاريخ :

05-07-2026

الطبيب المعالج :
د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
وزارة الداخلية

هــلـى

محمد عبدالحميد سلامة

٧ ش ابراهيم نصار ش عشرة

حدائق القبة - القاهرة

١٩٦٨/٠١/٠١

٢ ٦٨ ٠٤ ٠٢ ٠١ ٠٣ ٥ ٨٢

IC0507059

Name: هدي محمد عبد الحميد			
MR. : 1362			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient is receiving adjuvant therapy with femara (letrozole) and supportive care for a duration of three months, with an annual assessment planned. The next visit is scheduled after the completion of the three-month course.			
تحريرا في ,			
التاريخ :		20-09-2026	
الوقت :			
الطبيب المعالج :		علياء احمد أبو النصر شهاب الدين	
يعتمد ,			



٢٠١٩/٠٧ ٢٦٨٠٤٠٢٠١٠٣٥٨٢
حاصله على معهد فنى صناعى

أنشئ مسجلة



البطاقة مصرية حتى ٢٠٢٦/٠٧/١٣ ١





مملكة العربية السعودية
إدارة رئيس الجمهورية
لصحة المرأة الحضرية

الملكة رانيا
بنو

MDT FORM

21/1/2022

Name	فادي محمد العبد	MRN	100/00
Age	54 y.o	ID	57A.4.0.1.000
Menopausal status	postmenopausal	Phone	9-4.48800
OCP		marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

BR:	T1c G-II			R	fibrocystic nodule Kic hand mobil: T2 N0 M0 (cr)			
ER:	8/8	PR:	6/8	HER2:		2+	KI67:	
Sonomammography:				Rt. Multicentric mass + non mass 2.6x4cm retractor				
Mets Workup:				CT/PT → free				

Recommendations:

- Target
- ① Axilla u/s.
- ② Bone scan (adp)
- ③ Review of IHC (adp)
- ④ Echo
- ⑤ Labs.

MDT OUTCOME & PLAN

Measurable, start NAC (TCMP x6) with breast facts support guided by clinical response. Consider pt. SSF (not myelo-suppress) + SNBS (if target up mass).

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

000/1/00

Patient Name: Huda Mohamed AbdElhamid

Date: 31/3/2022

Tc-99m MDP bone scan.

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique:

Delayed Anterior and posterior whole body scan 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP.

Report:

Delayed Static Phase:-

- Degenerative changes are noticed over dorso-lumbar vertebrae.
- No definite hot spot that account for osseous deposits could be detected allover the surveyed skeleton.
- Both kidneys are normally seen

Conclusion:

- *The surveyed skeleton is free of osseous deposits.*

Thanks for reference

Nuclear medicine Unit

Dr. Omnia Talaat, MD

Dr. Sherine Mahdy, MD



Name : *Huda Mohammed*

Date : *06/03/2022*

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. Chest:

- Reported case of right breast cancer.
- No sizable pulmonary nodules.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous low CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Calculus gall bladder
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The scanned skeleton shows:
 - 1) Bilateral iliac tiny lytic lesions likely porotic .
 - 2) L4 small sclerotic focus likely bone island .
 - 3) D5 lytic with vertical striations mostly representing hemangioma

OPINION:

- *Reported case of breast cancer.*
- *No definite pulmonary or hepatic metastatic deposits.*

Dr. Mohammed Mohsen, MSc.

Dr. M. Gomaa, M.D.

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

جهة الاصدار : فرع القاهرة

تاريخ الاصدار : 2022-12-22

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) هدي محمد عبد الحميد سلامه بطاقة رقم 26804020103582
وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2022-12-22

الموظف المختص
سماح محمود



افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،



مسلسل 276192

يعتبر هذا الخطاب ساري لمدة شهر من تاريخ الاصدار

الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار

Patient Name	: الأستاذ / هدى محمد عبدالحamid سلامة	Request No.	: 13002623
Patient No.	: 26804020103582	Request Date	: 06/08/2022
Path No.	: 2214/22	Verification Date	: 24/08/2022
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 54 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Right breast cancer , MRM specimen:

-Invasive lobular carcinoma , grade II

-Actual tumor size : 0.5 cm

-Tumor cellularity :50%

-Free nipple & areola but reaching main lacteiferous ducts beneath the nipple

-Free deep margin

-Free LNs (0/15)

-Stage : ypT1a , ypN0

-rcb:2.354 , class : II

Prof.Amal Hareedy
Dr.Abdelrahman Ibrahim

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 29/05/2025 13:36:27

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

CAP
1000000

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - جسر النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

ليد محمد

Patient Name : الأستاذ / هدى محمد عبدالحديد سلام	Request No. : 13002623
Patient No. : 26804020103582	Request Date : 06/08/2022
Path No. : 2214/22	Verification Date : 24/08/2022
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer , post NACT

Nature of the specimen:

Rt MRM specimen , collected at 4/8/22

Gross Examination:

Rt MRM specimen measured 25x20x4 cm with covering skin ellipse measured 20x11cm

• Tumor extent

• Number: An ill defined rubbery to firm greyish white tumor bed side

• Size: 5x4x3 cm

• Skin involvement: Free grossly

• Distance from margins: 2 cm from deep margin

• Lymph nodes number and size: 15 LNs up to 1 cm

• Frozen section:

• Free SLNs(0/4)

Microscopic examination:

• Histological type: Invasive lobular carcinoma

• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

• Angiolymphatic invasion: No LVI

• Ductal carcinoma in situ: focal (< 5%)

• Skin involvement: Free nipple & areola but reaching main lactiferous ducts beneath the nipple

• Lymph node involvement: Free LNs (0/15)

• Resection Margins: Free deep margin

Diagnosis:

Verified by :

dr.esraa magdy



Patient's Name:

Date:

Referred by:

Hospital:

Huda Mohammed Abdul Hamid Salama
2026-08-08

Prof.Dr. no doctor

Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE CT EXAMINATION OF THE CHEST WITHOUT CONTRAST REVEALED:-

Known case of breast CA underwent right MRM.

- Few tiny bilateral scattered pulmonary nodules measuring 2-3 mm in diameter.
- No pulmonary masses, consolidation, collapse or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial effusion.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- Intact bony thoracic cage.
- Upper abdominal cuts showing few gall bladder stones.

Opinion:-

- ❖ Few tiny bilateral scattered pulmonary nodules likely inflammatory.
- ❖ Calculus gall bladder.

Dr.Sherif Wagdy



Patient's Name:

Huda Mohammed Abdul Hamid Salama

Date:

2026-08-08

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Left Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post right MRM & ALAND, followed by hormonal therapy for two years, routine follow up.

Findings:

Left breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections..
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.
-

Conclusion:-

- *Left breast (BIRADS 1): normal study.*
- *Clear right mastectomy bed and axilla.*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. Nehal Fouda,MD